



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RORAIMA
COMARCA DE BOA VISTA
2ª VARA CÍVEL - PROJUDI

Centro Cívico - Fórum Adv. Sobral Pinto, 666 - 2º andar - Centro - Boa Vista/RR - CEP: 69.301-380 - Fone: (95) 3198-4755 -
E-mail: 2civelresidual@tjrr.jus.br

Proc. n.º 0803074-46.2024.8.23.0010

SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, proposta por Bernardo Fernandes Pagote, menor, representado por seus genitores Lucas Pagote Costa e Liwia Ellen Fernandes Severo da Silva, contra Amil Assistência Médica Internacional S.A.

O autor relatou que é usuáριο do plano de saúde administrado pela parte ré e que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID 10: F84.0), sendo-lhe prescrito por médico neurologista especificamente o Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Prosseguiu informando que pleiteou da ré a cobertura do referido tratamento, tendo a empresa informado (em 30/10/2023) que autorizava a realização do tratamento na Clínica Autismo em Vista.

Ocorre que a empresa não entrou mais em contato para realizar o pagamento dos serviços, razão pela qual o menor teve suspenso o direito a continuidade do tratamento.

Destacou que tentou diversas vezes contato com a empresa, sem sucesso.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência, para que a parte ré efetuasse os pagamentos pendentes em favor do Instituto de Ensino e Pesquisa Autismo em Vista, a fim de que o menor desse continuidade ao tratamento prescrito pelo médico. No mérito, pleiteou a que a ré custeie integralmente o tratamento do autor de forma regular, e realize o pagamento das notas em favor da clínica de forma mensal e em dia, bem como requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$ 5.000,00.



A inicial veio acompanhada de documentos (EPs 1.2/1.16).

Concedida a medida liminar requerida (EP 6) e deferida a gratuidade de Justiça ao autor.

No EP 13, a autora emendou a inicial com pedido de tutela incidental pleiteando novamente por medidas em favor do menor, em razão do surgimento de novos fatos, pois descobriu que os atendimentos realizados nas clínicas Colorê e Lamos, ambos autorizados previamente, também foram suspensos em razão da falta de pagamento da empresa ré. Nesse contexto, a autora requereu, liminarmente, que a parte ré efetuasse os pagamentos pendentes nas duas clínicas a fim de que o menor desse continuidade ao tratamento prescrito pelo médico. Juntou documentos nos EPs 11.1/11.22

Recebida a emenda a inicial e concedida a liminar requerida para determinar que a parte ré promovesse o pagamento pendente nas clínicas Lamos e Colorê, a fim de garantir a continuidade do tratamento que vinha sendo realizado com o menor, ou, em caso de impossibilidade, que designasse novas clínicas para realização do referido tratamento, na forma prescrita no laudo médico (EP 13).

No EP 18, a parte autora informou o descumprimento da liminar.

Decisão que aplicou a multa estabelecida, no valor de R\$ 3.500,00 (EP 22).

A audiência de conciliação não foi frutífera (EP 32).

Manifestação do Ministério Público no EP 35.

Citada (EP 16), a ré apresentou contestação no EP 19, aduzindo, em sede preliminar, a incorreção ao valor da causa e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou que não houve demonstração, por parte do autor, de que as clínicas disponibilizadas pela requerida não são aptas a realização do tratamento, nem mesmo que houve recusa de atendimento em referidas clínicas e que o plano de saúde não é responsável por custear o tratamento fora do rol da ANS e sem cobertura.

Réplica ao EP 25.

Decisão saneadora proferida ao EP 29, afastando as preliminares arguidas e anunciando o julgamento antecipado da lide.

No EP 37, a parte autora informa o descumprimento da medida liminar por parte da ré.

É o relatório. Decido.

Como visto, trata-se de ação cominatória positiva c/c reparatória, ajuizada em virtude de suposta falha na prestação de serviço de saúde.

Apurou-se que o autor foi diagnosticado como sendo portador do transtorno do espectro autista - TEA, buscando precipuamente o reconhecimento da obrigação da sua operadora de plano de saúde – a parte ré – de custeio do tratamento do autor com: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA, bem que a ré realizasse o pagamento pendente das clínicas Lamos e Colorê, a fim de garantir a continuidade do tratamento que já vinha sendo realizado com o menor.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a parte ré argumenta, principalmente, que não houve demonstração, por parte do autor, de que as clínicas disponibilizadas pela requerida não são aptas a realização do tratamento, nem mesmo que houve recusa de atendimento em referidas clínicas e que o plano de saúde não é responsável por custear o tratamento fora do rol da ANS.

Neste contexto, tem-se que o cerne da demanda corresponde à obrigação ou não da ré em custear o tratamento em relação ao Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA, destinada ao tratamento do autismo que acomete o autor, bem como se a operadora de plano de saúde é obrigada a manter o tratamento do autor com profissional ou clínica não integrante da rede credenciada da operadora ré.

A pretensão autoral merece prosperar parcialmente. Vejamos.

Ao compulsar os autos, observa-se que o autor, por volta dos 4 anos de idade foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA (CID10 F84.0), sendo prescrito terapia adequada a sua faixa etária, promovida por equipe multidisciplinar especializada em metodologias específicas de trabalho para portadores de autismo (EPs 1.12 e 1.16).

Verifica-se também que os genitores do autor solicitaram ao plano da ré o custeio do tratamento (EPs 1.11/1.15), o qual foi deferido, contudo, houve suspensão do tratamento em virtude da falta de pagamento (EP 1.24).

Nesta conjuntura, tenho que deve ser fornecido o tratamento prescrito, devidamente custeado pela ré, seja por força da legislação e jurisprudência que rege o caso dos autos, seja, em paralelo e inserido neste contexto, pela evidente necessidade e importância do supracitado tratamento para o melhor desenvolvimento do autor.

Acerca da importância crucial da terapêutica pelos referidos métodos implementados no tratamento



do autor, infere-se tal a partir das declarações e laudos médicos anexados aos autos que se toma por indispensável e devido o custeio do tratamento postulado pelo autor por parte da ré, com os profissionais habilitados para executar os procedimentos, vetor da boa evolução e desenvolvimento do paciente.

O ordenamento vigente sedimenta tal obrigação no contexto dos autos. De início, note-se que o autismo que acomete o autor está devidamente inserido na Classificação Internacional de Doenças (CID10 F84.0), o que garante, de maneira introdutória, a cobertura dos tratamentos respectivos com base no art. 10, *caput*, da Lei 9.656/98, aplicável à lide.

Além disso, a Lei nº 12.764 /12, que instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multidisciplinar a paciente diagnosticado com espectro de autismo, não prosperando, portanto, a negativa ou suspensão do tratamento.

Cabe destacar, ainda, que quanto aos pacientes portadores do transtorno de espectro autista, foi editada a Resolução nº 539/2022 da ANS que alterou a Resolução Normativa nº 465, ampliando as regras de cobertura para tratamento destes pacientes e destacando que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, *in verbis*:

Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Logo, cabe ao médico assistente a escolha da conduta terapêutica mais eficaz para o tratamento da moléstia, de forma que deve ser assegurado o custeio de todo o tratamento prescrito (Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - SAÚDE SUPLEMENTAR - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - ATENDENTE TERAPÊUTICO (AT - APLICADOR ABA) - AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO PELA REDE CREDENCIADA - REEMBOLSO INTEGRAL. 1. É direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo-se o atendimento multiprofissional - art. 3º, III, b, Lei nº 12.764/2012. 2. A partir da Resolução Normativa ANS nº 539, de 23 de junho de 2022, é obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o

tratamento de paciente portador de transtorno do espectro autista. 3. Na ausência de prestadores na rede credenciada, o reembolso deve ser realizado de forma integral - art. 4º e 9ª da Resolução Normativa da ANS nº 259/2011. (TJ-MG - AI: 10000220182679003 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)”

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto , 123, 4º andar, RECIFE - PE - CEP: 50030-260 - F:() Agravado de Instrumento n. 0010131-83.2022.8.17.9000** Agravante:Heloisa Ferreira Duarte Bezerra Agravada: Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico Relator: Eduardo Sertorio Canto EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE CLÍNICA NA REDE CREDENCIADA APTA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELA SEGURADORA. ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO EM DOMICILIO E ESCOLA. DEVER DE COBERTURA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela pleiteada, além da probabilidade do direito, faz-se necessária a configuração doperigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.Agravante diagnosticada com transtorno do espectro autista - TEA, sendo recomendado por sua médica assistente tratamento com equipe multidisciplinar. 3.A mera disponibilização de clínica credenciada,por si só,não é suficiente para configurar a capacitação em relação ao tratamento do segurado.Perícias médicas realizadas no bojo de outros processos atestando a inabilitação das ClínicasCEFOPEe CEAM para o tratamento adequado às pessoas com autismo. Clínica Fases não apresentou resposta sobre a capacidade e habilitação dos profissionais a fim de atender o tratamento prescrito. As Clínicas Bem Estare Equilíbrio não foram indicadas na via administrativa, tendo sido apenas indicadas em sede agravo interno, sem a demonstração de aptidão e disponibilidade de horário para realização do tratamento da paciente de forma uniforme. 4.A Seguradora não comprovou a existência de profissionais e estabelecimentos credenciados, aptos para o tratamento multidisciplinar especializado necessário para o Segurado. 5. **A Lei n. 12.764/12 não deixa dúvida sobre o direito do portador de autismo ao atendimento multiprofissional, bem como o acesso integral a todas as suas necessidades de saúde. No mais, a ANS editou a Resolução Normativa nº 539/2022, que alterou a Resolução Normativa nº 465/2021, definindo que a partir de 1/7/2022, os planos de saúde suplementares estão obrigados a cobrir qualquer método ou técnica indicado pelo médico ou dentista assistente, para o tratamento do paciente com Transtorno do Espectro Autista.** 6. Foge à alçada da magistratura indicar nominalmente os profissionais que devem ser pagos pelo plano, ainda mais quando eles estão fora da rede credenciada. Nesse contexto, não pode haver direcionamento nesta decisão para profissionais específicos. 7. Deve haver, portanto, a cobertura do tratamento por profissionais habilitados, mesmo fora da rede credenciada, de escolha do agravante entre os especializados nos métodos necessários ao seu tratamento. 8. Dado provimento ao agravo de instrumento para condenar a Seguradora agravada a arcar com todas as



despesas referentes ao tratamento multidisciplinar especializado requerido, nos termos do laudo médico. 9. Com o julgamento deste recurso, resta prejudicado o agravo interno. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos do agravo de instrumento n.0010131-83.2022.8.17.9000, em que figuram como partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, na conformidade do relatório, do voto, da ementa e das notas taquigráficas, que integram este julgado. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator (TJ-PE - AI: 00101318320228179000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto)”

Assim, da interpretação sistêmica da legislação de regência aliada ao entendimento jurisprudencial, pode-se subsumir com clareza o dever da ré de cobrir o tratamento necessitado pelo autor.

Desse modo, imperioso é o reconhecimento da obrigação da ré de custear integralmente, em favor do autor, o tratamento prescrito, qual seja, Tratamento de Terapia Comportamental, por meio da aplicação do método ABA, compreendendo as terapias de: Fonoterapia, Psicologia, Psicopedagogia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA.

Por outro lado, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a operadora do plano de saúde, a princípio, não está obrigada a custear tratamento médico em estabelecimentos não constantes da sua rede credenciada.

O custeio integral de tratamento por outros profissionais ou estabelecimentos médicos pressupõe a inexistência de serviço específico em sua rede credenciada ou em caso de situações de caráter de urgência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FONOAUDIOLOGIA. REEMBOLSO DE DESPESAS. DESNECESSIDADE DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento." (EAREsp 1459849/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 17/12/2020). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7

do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade de tratamento fora da rede credenciada. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das cláusulas contratuais e do contexto fático. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1888390 CE 2020/0199364-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

Portanto, o tratamento fora da rede credenciada é exceção, uma vez que não é dado ao segurado a livre escolha dos profissionais médicos que realizam o tratamento, sobretudo quando a operadora dispõe de profissionais capacitados, sob pena de risco aos princípios da boa-fé objetiva e o do equilíbrio contratual.

Com efeito, em que pese a ré ter inicialmente, indicado as clínicas Lamos e Colorê, ao que parece, estas não mais fazem parte da rede conveniada, de forma que a ré teria credenciado a clínica mãe de Deus para atendimento médico ao autor (EP 19.6).

Portanto, o que há é a obrigação de o convênio seguir custeando o tratamento nas mesmas condições de cobertura assistencial, de modo a não desamparar o autor, portador de condição que demanda cuidado terapêutico contínuo.

Por fim, não prospera o pedido para que a ré efetue os pagamentos pendentes nas clínicas Lamos e Colorê, a fim de que o menor dê continuidade ao tratamento prescrito pelo médico. Ressalte-se que cabe as referidas clínicas, se for o caso, intentarem ação quanto a eventuais serviços prestados e não pagos pela ré.

Assim, conforme fundamentação supra, não há obrigação do custeio de tratamento fora da rede credenciada, quando existe profissional capacitado na rede conveniada.

Quanto ao pedido de **indenização por danos morais**, tenho que ele deve ser acolhido.

Com efeito, é tranquilo o entendimento no STJ de que há dano moral indenizável nas hipóteses em que a operadora de plano de saúde recusa a autorização de tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada (AgInt no REsp n. 1.841.742/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020), que foi justamente o que ocorreu no presente caso, tal como reconhecido acima.

De fato, a recusa de tratamento devido, demora injustificada a autorização do tratamento ou té mesmo a suspensão do tratamento de forma injustificada, sobretudo no caso da doença que acomete o autor – um transtorno do neurodesenvolvimento que demanda estimulação contínua –, tem potencial afetação sobre o próprio futuro da criança, atingindo, sem sombra de dúvidas, a esfera da personalidade.

No que diz respeito ao valor da indenização, entendo que o *quantum* razoável e adequado ao caso deve ser de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).



Sendo assim, pelo aspecto fático e fundamentos jurídicos expostos anteriormente, acolho os dois pedidos formulados na inicial, julgando **parcialmente procedente a pretensão autoral**, e extinguindo, por consequência, o processo, com resolução do mérito, na forma do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré à obrigação de garantir o tratamento do autor com fonoterapia, psicologia, psicopedagogia, musicoterapia, Terapia Ocupacional e Terapia Intensiva Comportamental ABA, os quais deverão ocorrer em rede credenciada ou em rede particular (caso o plano de saúde não possua profissional habilitado), sem qualquer vinculação com profissional ou clínica, no prazo de 30; além disso, **reconheço a exigibilidade da ré em obrigação de pagar quantia certa, condenando-a ao pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)**, a título de **indenização por danos morais**, corrigidos monetariamente pelo índice oficial deste Tribunal, a partir da publicação desta decisão, acrescidos de juros legais de mora (1% a.m.), a contar da citação válida nos autos.

Ante a sucumbência recíproca dos litigantes, os honorários advocatícios deverão ser distribuídos em 70% para a ré e 30% para o autor (art. 86, *caput*, CPC), sendo a verba honorária fixada em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Observada a suspensão em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

Sem ressarcimento de despesas processuais, visto que não houve adiantamento de valores desta natureza pelo autor nos autos.

Considerando as informações de EP 37, na qual a parte autora aduz a suspensão do tratamento do menor, intime-se a ré para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o efetivo encaminhamento do menor à clínica credenciada para realização do tratamento médico prescrito, sob pena de ser imposta a multa estabelecida no EP 13.

Intimem-se a parte autora eletronicamente.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as devidas baixas no sistema, sem prejuízo de ulterior reabertura do trâmite, para fins de cumprimento de sentença.

Boa Vista, segunda-feira, 3 de junho de 2024.

Angelo Augusto Graca Mendes

Juiz de Direito

(Assinado Digitalmente - Sistema CNJ – PROJUDI)

